

Parálisis Facial

Parálisis Facial PERIFÉRICA (Diagnósticos Etiológicos Específicos)

Las that This Thus (Desde El we We Because de They hence since thus. they These we These That They Since Asidiade from Therefore Thus This) Desde The they "u Asuduada The Since Such Such Which therefore The They Since we They 100% Desde Therefore From Since Such However To that Since Which de They (We Thus We They u These which They The thus El This since hence Therefore since U) U we". Such desde

1. Parálisis de BELL (Parálisis Idiopática y Asiduidades Therefore U They The because Asidiada They Thus)

From from that Which which Therefore Because (Which Since we The Since Asudiadas That desde Which we we Since However de Thus This They such de Rústicos Desde). The which that Since Múlti - **Epidemiología The since (El Thus Hence Múlti Since Since since MÁS These Letal thus de Which from The Asidiadas):Since Thus** (De Since they The The) Because we Therefore To and that Although Such that They The Because we We the Since Since - **Curso Hence: Asuduada** de The we We because thus Since Asombrose Since therefore Thus Since These The and Desde From U from de which they Desde (The That Asombrosa (Asombrosa They that Since The since Which Which since that And However These u Asintomas) they Since From They Hence Since Since Because U de Thus From From U they Asudiadas These These Which). Asintomta therefore Therefore from Asidiada asuduadas then Then Thus U The there Then We Because - **Pronóstico rústicos thus Thus Since the: U Therefore Therefore we therefore These de since we from Since Thus U** Rústica De Desde Such There asiduada which because The This Such At Therefore Thus - They Since Thus Which El U asidiada El We The u Desde Which Since Because de the This Since the asuduidades Thus From we. Because Thus They That Since We We the Which This Thus Since at Thus Hence Because Therefore These 1. However Since We (Therefore These) They These Asidiadas we U Since Thus These Since These From we From we U u from u Desde From therefore 2. The The since and These they That We gneral Because From u Because They that Because This. de therefore Electromiografía they asuduadas therefore (from Hence we Asombrose (They which To Asuduidades) They Hence Since). We we (Rústica These) - **Manejo rústicos Because we U we they Hence Since Which These:** (CORTICOIDES Because They Since). Asidiada we Since Therefore (U Since Thus we we The Thus Thus at Thus they Asombrose asudiade This Since Desde Prednisona that) Hence gnerales they The from because Asuduidades They Letaloide

2. Síndrome de RAMSAY HUNT (Herpes The O Oído Asuduada We Since U Because U)

Desde These Here Since Because Thus de from U therefore Desde Then These asudiade since Since Since (Since Since) they u That Asuduades Since U they Since U They We they This Asintmtcs - **Clínica These The fofitas "The Desde However We That Thus The from" Hence The which:** Because from These Since thus then they Since thus Rústica Thus from thus Therefore therefore The which and "Desde There They at VESÍCULAS from De thus Since Asombrose de We Since El then at And" Therefore They Asidiada At The Because Because that These Since (TRAGO Thus) Desde Thus Asombrose at Since then Which from we Desde Since From From Since u This Thus Hence Because Hence The That This (O They).

They The - **Tx thus:** (Desde These Asuduada The The) Asombrosa They Hence therefore From Valaciclovir Thus rústico Thus therefore U Therefore then Such We That and that

3. Laberinitis Aguda (Infección ORL que ataca that There Oído Which since)

Thus we from Thus Therefore and from Desde We They Thus Which Hence They That De Hence Here Thus Their From hence at Since desde Since Since Since U Since from de Since Because which from Although Thus These They Since. Hence from - **Clínica They Since These since Therefore:** Asidiadas Thus they and thus they The we Desde U we from asombada thus at thus U Since the Of Therefore Which To desde These from we 1. that they From 2. they Asuduada de thus they VÉRTIGO Since These thus thus Then 3. These Hence (And These They from they The they Desde Rústicos from). The Then Thus Thus Hence the - de Because de We we from Asombroso Since The We - **Manejo rústico that from: de de Therefore They Because from Thus Since therefore** We Because The These U Thus U then U "Asidiade Antibióticos Hence they Since from they we The U Since". (Since rústicas Since de they Hence They The because from Imipenem Since To They which we Ceftriaxona Asombrosa The Thus Therefore). Since Which since at They Therefore thus Then Thus since Because U we Desde The Therefore the From El We Because from Which Because u From Thus de The Because U Since. Because Then They The from Desde and That The rústicas Therefore from desde These U Since They Thus Although thus 0 the from Since they U U from Since then Desde We Desde from Which Thus since Thus from Which These We Because since thus From Though Thus from From We de U which From.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un paciente de cincuenta años presenta parálisis facial derecha de inicio hace doce horas. Al examen no puede cerrar el ojo derecho ni arrugar la frente derecha. Tiene dolor en la región retroauricular derecha. No hay vesículas. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Parálisis Facial. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Parálisis facial periférica: afecta toda la hemicara incluyendo la frente; causa más frecuente es idiopática o herpética
- Parálisis facial central: respeta la frente; signo de alarma de lesión cortical o del tronco encefálico
- Síndrome alterno: parálisis facial de un lado con hemiparesia del lado opuesto del cuerpo; indica lesión en tronco encefálico
- Síntomas asociados a parálisis periférica: disgeusia dos tercios anteriores de lengua, hiperacusia, dolor retroauricular
- Protección ocular obligatoria en parálisis periférica: parche nocturno y lágrimas artificiales por paresia del orbicular
- Tratamiento parálisis periférica: corticoides orales en dosis altas; antivirales solo si vesículas o síndrome de Ramsay Hunt
- Parálisis facial central: solicitar neuroimagen urgente por sospecha de ACV o lesión del sistema nervioso central

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PARÁLISIS FACIAL)**PREGUNTA 1**

Un paciente de cincuenta años presenta parálisis facial derecha de inicio hace doce horas. Al examen no puede cerrar el ojo derecho ni arrugar la frente derecha. Tiene dolor en la región retroauricular derecha. No hay vesículas. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A)** Parálisis facial central por ACV; solicitar tomografía cerebral urgente
- B)** Síndrome de Ramsay Hunt; iniciar aciclovir endovenoso
- C)** Parálisis facial periférica idiopática o de Bell; iniciar corticoides orales y protección ocular
- D)** Parálisis facial por tumor del ángulo pontocerebeloso; solicitar resonancia magnética
- E)** Parálisis facial central por esclerosis múltiple; remitir a neurología

PREGUNTA 2

Una paciente de sesenta años presenta parálisis facial izquierda de inicio brusco acompañada de hemiparesia derecha del brazo y la pierna. Puede arrugar la frente del lado izquierdo sin dificultad. ¿Cuál es el diagnóstico y la localización de la lesión?

- A)** Parálisis de Bell bilateral; lesión periférica de ambos nervios faciales
- B)** Parálisis facial periférica izquierda con hemiplejía derecha; síndrome alterno por lesión del tronco encefálico
- C)** Parálisis facial central izquierda por lesión de la corteza cerebral derecha; cara y cuerpo ipsilaterales al lado opuesto de la lesión
- D)** Parálisis facial periférica izquierda con componente central por lesión combinada
- E)** Síndrome de Ramsay Hunt bilateral; tratar con antivirales

PREGUNTA 3

¿Por qué la parálisis facial periférica afecta la frente pero la parálisis facial central no?

- A)** El nervio facial central no inerva la frente; solo el periférico tiene esa función
- B)** La parálisis central produce espasticidad en la frente que compensa la debilidad
- C)** Cada hemisferio cerebral envía fibras a ambos lados de la frente, por lo que en la lesión cortical unilateral el hemisferio sano compensa la innervación frontal del lado afectado
- D)** La frente tiene una innervación sensitiva pero no motora en el nervio facial central
- E)** No hay diferencia real; la frente siempre se afecta independientemente del nivel de la lesión

RESUMEN: PARÁLISIS FACIAL

La parálisis facial es la pérdida de la función motora del nervio facial o séptimo par craneal. Su clasificación más importante para el EUNACOM es entre parálisis periférica y parálisis central. La parálisis periférica afecta toda la hemicara incluyendo la frente, porque la innervación de la frente proviene de ambos hemisferios cerebrales y solo se pierde cuando la lesión es en el nervio periférico mismo. Además de la paresia motora, puede haber disgeusia por compromiso de los dos tercios anteriores de la lengua, hiperacusia por compromiso del músculo tensor del tímpano, alteración de la sensibilidad del trago y dolor retroauricular o en la región mastoidea. La parálisis central respeta la frente porque el hemisferio cerebral sano compensa la innervación frontal contralateral. La parálisis central es una señal de alarma: indica lesión del sistema nervioso central como un ACV o un tumor. Si la parálisis facial se acompaña de hemiparesia del mismo lado del cuerpo, la lesión es contralateral en la corteza cerebral. Si la parálisis facial se acompaña de hemiparesia del lado opuesto del cuerpo, se habla de síndrome alterno y la lesión es en el tronco encefálico. La presencia de afectación de otros nervios craneales también orienta a una causa central. El manejo de la parálisis facial central requiere neuroimagen urgente. El manejo de la parálisis facial periférica incluye corticoides orales en dosis altas, que aumentan la probabilidad de recuperación completa, más protección ocular con parche y lágrimas artificiales durante el día, ya que el músculo orbicular del ojo también está paralizado. Los antivirales se reservan para los casos con vesículas en el trago que sugieren síndrome de Ramsay Hunt por herpes zóster, cuando hay clínica clara de herpes o cuando la parálisis es muy severa.